

LETTERA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

Date (auto): 2026-03-18

Document ID: healthclarify-ips-it-01

DATI DEL PAZIENTE

Nome Giovanni Rossi
Età 64
Sesso male

ALLERGIE

- Penicillina - rash maculopapulare diffuso (documentato 2018)

ANAMNESI CLINICA

- Ipertensione nota da 5 anni in monoterapia; controllo pressorio subottimale negli ultimi 12 mesi.
- Diabete mellito di tipo 2 diagnosticato 8 anni fa; in terapia con metformina 1000 mg due volte al giorno.
- Fumatore attivo (~30 pack-year); aveva rifiutato in precedenza la cessazione.
- Nessun infarto miocardico, ictus o insufficienza renale cronica pregressi.
- Padre deceduto per morte cardiaca improvvisa a 60 anni.

VALORI DI LABORATORIO ALLA DIMISSIONE

- Troponin I.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma: 14200 ng/L (< 14)
- Cholesterol [Mass/volume] in Serum or Plasma: 245 mg/dL (< 200)
- Cholesterol in LDL [Mass/volume] in Serum or Plasma: 160 mg/dL (< 100)
- Cholesterol in HDL [Mass/volume] in Serum or Plasma: 32 mg/dL (> 40)
- Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood: 7.8 % (< 6,5)
- Creatinine [Mass/volume] in Serum or Plasma: 1.1 mg/dL (0,6-1,2)
- Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted: 68 mL/min/1,73m² (> 60)
- Left ventricular Ejection fraction: 45 % (> 55)

DIAGNOSI DI AMMISSIONE

Infarto miocardico acuto transmurale anteriore con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI)

DIAGNOSI SECONDARIE

- Ipertensione arteriosa essenziale
- Diabete mellito di tipo 2 senza complicanze
- Iperlipidemia mista
- Disturbo da uso di tabacco (fumatore attivo, ~30 pack-year)
- Storia familiare di coronaropatia prematura

PROCEDURE ESEGUITE

- Angioplastica coronarica percutanea primaria (PCI) per via radiale destra
- Impianto di stent medicato (DES) in arteria discendente anteriore sinistra (LAD) prossimale
- Flusso TIMI 3 ripristinato dopo PCI
- Terapia antiaggregante piastrinica doppia (DAPT) avviata (aspirina + ticagrelor)
- Avvio della Riabilitazione Cardiologica Fase I prima della dimissione

DECORSO CLINICO

Paziente maschio di 64 anni, fumatore, con ipertensione e diabete di tipo 2, giunto in Pronto Soccorso per

LETTERA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

dolore toracico gravativo retrosternale irradiato all'arto superiore sinistro, diaforesi e dispnea progressiva a minimo sforzo, della durata di circa 90 minuti. L'elettrocardiogramma ha mostrato sopraslivellamento del tratto ST ≥ 2 mm nelle derivazioni V1-V4, indicativo di infarto miocardico acuto anteriore con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI). Il paziente è stato trasportato d'urgenza in sala di emodinamica. La coronarografia ha documentato un'occlusione trombotica del 95% della arteria discendente anteriore sinistra (LAD) prossimale. È stato impiantato con successo uno stent medicato (drug-eluting stent), ripristinando un flusso TIMI di grado 3. Il picco di troponina I ad alta sensibilità ha raggiunto 14.200 ng/L. L'ecocardiografia transtoracica post-procedurale ha documentato una frazione di eiezione del ventricolo sinistro lievemente ridotta (45%), con ipocinesia della parete anteriore e del setto interventricolare. La doppia terapia antiaggregante è stata proseguita. Il paziente è rimasto emodinamicamente stabile, senza recidiva di dolore toracico né aritmie, ed è stato considerato idoneo alla dimissione con follow-up cardiologico strutturato ed arruolamento al programma di riabilitazione cardiologica.

FARMACI ALLA DIMISSIONE

Farmaco	Dosaggio	Indicazione	Orario
Acetylsalicylic acid	100 mg al giorno	Antiaggregante - previene la formazione di trombi	Mattina
Ticagrelor	90 mg due volte al giorno	Antiaggregante - protegge il nuovo stent	Mattina e sera
Atorvastatin	80 mg al giorno	Riduce il colesterolo e stabilizza le placche	Sera
Ramipril	2,5 mg al giorno	Protegge il cuore e controlla la pressione	Mattina
Metoprolol	25 mg al giorno	Rallenta il battito cardiaco e protegge il cuore	Mattina
Metformin	1000 mg due volte al giorno	Continuazione della terapia per il diabete	Mattina e sera

ISTRUZIONI DI FOLLOW-UP

Controllo cardiologico ambulatoriale tra 14 giorni. Diario quotidiano della pressione arteriosa domiciliare. Counselling per cessazione del fumo entro 7 giorni. Riabilitazione cardiologica Fase II in 3 settimane. Ripetizione di profilo lipidico, HbA1c e funzione renale a 3 mesi.

SINTOMI DI ALLARME — CHIAMARE IL 112 SE:

- ! Dolore o pressione toracica ricorrente della durata superiore a 5 minuti
- ! Affanno (mancanza di respiro) a riposo o peggioramento notturno
- ! Capogiri improvvisi, svenimento o pre-svenimento
- ! Gonfiore improvviso delle caviglie o delle gambe
- ! Sanguinamento che non si arresta entro 10 minuti (in corso di terapia antiaggregante)
- ! Qualsiasi nuovo sintomo neurologico (debolezza, eloquio impastato, perdita della vista)

LETTERA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

Documento sintetico e anonimizzato generato a scopo dimostrativo per HealthClarify. Non è un documento medico reale.